

INDICADO POR: Dr. Gisel (Cardio)

☒ ACOMPANHAMENTO ☐ CONSULTA

NS 537624974C189

ALEXANDRE ALVES MENDES

IDADE: 46 PESO: 104 ALTURA: 1,80 PROFISSÃO: TI

SINTOMAS: Enxaquecas noturnas
Parava de respirar à noite e batia as costas na parede p/ voltar.

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Paroxetina / Rosuvastatina

MÉDICO: Dr. Gisel (Cardio)

MARCAPASSO: ☐ S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: ☐ S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: sedentário

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 20-21h

HORA QUE DORME: 22:30-23:30 HORA QUE ACORDA: 7h

COCHILHO: ☐ S ☒ N DORME ACOMPANHADO: ☒ S ☐ N ☐ EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S ☐ N / DORMEM NO QUARTO: ☐ S ☒ N PET NO QUARTO: ☐ S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: ☐ S ☐ N NA SEMANA ☒ NFUMO: ☐ S ☐ N MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: não

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gélido CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: I IAH: 203 e/h SPO2: 82%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: ☐ NASAL ☐ AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: ☒ RESPIRATÓRIA ☒ ENDÓCRINA ☐ CARDÍACA☒ ORTOPÉDICA ☒ NEUROLÓGICA ☐ OUTROS:POLISSONOGRAMA COM CPAP: ☐ S ☐ N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

30/05/25 Arreioção

Maxe dream wear

P= 4-10

M. de uso: 6h30'

(17)

Natasha

06/06 P= 6,2 cm/H₂O

adaptou porém.

IAH= 2,0 e/h

M. de uso: 6h30'

boa adesão

13/06 P= 6,2 cm/H₂O

Indiquei melatun.

IAH= 2,5 e/h

M. de uso: 6h00'

boa.

27/06 P= 6,2

Roncou, está resfriado

IAH= 2,4 e/h

M. de uso: 6h34'

boa.

Fuga= 3,4 e/h

$p = 7 \text{ atm H}_2\text{O}$
 $\Delta H = 8,3 \text{ e/h}$

made exo: 6h31

Compton Philips

$\uparrow p = 7,5 \text{ cm H}_2\text{O}$

natacha

ALEXANDRE ALVES MENDES

PROFESSOR

ARTICLE

2014

ALMOLO

DAS REFEIÇÕES: CAFÉ

107

12

QUANTO TEMPO
BANNEIROLOITE

CIRCUNFERENCIA PESCO

2902

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (02), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório moderado (20,3 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina normal (91%);
3. Aumento da latência para o início do sono (208,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM normal (115,0 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono diminuída (48,4 %) (VN= ≥ 85%);
6. Aumento do índice de despertares (21,2 n°/h) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (3,5 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (48,7 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (22,4 %) (VN= 13% a 23%);
10. Ligeiro aumento do percentual do estágio REM (25,4 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, constante verificado via sensor de ronco;
12. Presença de movimento periódico de membros inferiores com índice aumentado (68,9 (n°/h) (VN= até 15 n°/h);
13. Presença de atividade em EMG de queixo.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

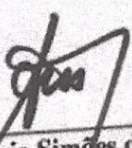
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau moderado, associado a distúrbio de movimento. Presença de bruxismo.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: ALEXANDRE ALVES MENDES

Data do Exame: 05-03-2025

pág. 2